

業務継続計画（BCP）

さくら内科クリニック

 外来専門クリニック

診療科：内科・循環器科

作成日：2026/4/25

Version 3.0（たたき台）

 **これはBCPのたたき台（自動生成版）です。**スタッフ全員で内容を確認・修正してください。特に地域のハザードマップ確認、スタッフとの合意形成、連携機関との調整が必要です。

✦ 本BCPは、[厚生労働省「医療施設の災害対応のための事業継続計画（BCP）」](#)等の公的ガイドラインを参考に作成しました。

第1章 BCP策定の目的と基本方針

1.1 策定の目的

さくら内科クリニックは、内科・循環器科を専門とする外来専門クリニックとして、外来診療・健康診断・予防接種等の形で地域医療を担っている。

当院の理念・基本方針：

- 地域の皆さまが安心して受診できるクリニックを目指す
- 有事においても外来診療を途切れさせず、患者のいのちと生活を守ることを最優先にする

有事においても外来診療を継続できるよう、また万が一中断せざるをえない状況になった場合でも、平時から地域医師会・近隣の病院・診療所等との連携によりサービス提供を継続し、早期復旧を目指すために、ここに業務継続計画（BCP）を策定する。

さらには、地域全体でPreventable Disaster Death（PDD：防ぎ得た災害関連死）の阻止に努め、地域包括ケアシステム構築の文脈の中で、周辺の医療介護福祉機関や行政との連携をベースとする「地域BCP」へとつなげていく。

1.2 基本方針

- スタッフのいのちと安全を最優先にする
- 患者のいのちと生活を守る 医療提供を途切れさせない
- 地域住民の助けとなる

- スタッフの権利と意思を尊重する

1.3 BCP策定・管理体制

役割	氏名・役職	主な責務
BCP統括責任者（第1指揮者） 院長	桜山 太郎（院長）	BCP発動宣言・全体統括・対外連絡
第2指揮者	桜山 花子（副院長・事務長）	第1指揮者不在時の代行
第3指揮者	山田 一郎（看護師長）	第2指揮者不在時の代行
副BCPリーダー	桜山 花子（副BCPリーダー）	BCPリーダー補佐・現場調整
BCP管理担当者	桜山 花子（BCP管理担当）	平時のBCP管理・訓練・見直し主導
見直し頻度	年1回（毎年4月）・大規模訓練後	

第2章 当院のリスク分析

2.1 立地・環境特性

リスク 種別	当院の状況・特徴
地震	横浜市北部地震・東海地震の影響範囲内。最大震度6強想定。
洪水・ 浸水	鶴見川流域の洪水リスクあり。クリニック周辺は比較的安全な立地。
津波	海岸から約10km。津波浸水想定区域外。
土砂災 害	周辺は平坦地。土砂災害リスクは低い。
停電	台風時に過去1回停電あり（約2時間）。電子カルテへの影響を要対策。
感染症	新興感染症流行時はスタッフ・患者への感染リスクがある。訪問診療の特性上、訪問継続可否の判断基準を平時から整備しておく。
停電・ 通信障 害	電子カルテ・医療機器の停止、在宅酸素・人工呼吸器患者への重大な影響。固定電話・FAXのみでは有事に機能しない。ICTの平時からの有事活用ルールを整備しておく。
サイバー 攻撃	電子カルテ停止・患者情報漏洩・レセプト送付不能のリスク。定期バックアップ・アクセス管理・外部委託先との対応手順を事前整備しておく。
人為的 リスク	交通事故・多数傷病者発生によるスタッフ不足・救急搬送増加・往診依頼急増。近隣医療機関との連携協定を平時から整備しておく。

2.2 スタッフの出勤可否分析

大規模災害時、スタッフが自力で徒歩出勤できるかは距離に依存する。詳細は「スタッフ出勤表」タブを参照。

スタッフ合計：12名

医師S.Y. (0.8km・徒歩)・H.Y. (3.2km・自転車) は0.8km圏内のため、車等で比較的短時間での参集が期待できる。

要配慮スタッフ（育児中1名（K.F.））については安全確保を最優先とし、出勤を強いない。

※ 徒歩・自転車出勤の目安：概ね4km以内（徒歩約60分・自転車約20分）を「参集可能圏内」と設定する。

第3章 業務の優先度と継続計画

3.1 業務の優先度分類

分類	業務内容	復旧目標
優先継続	緊急外来診療・処置、患者安否確認、スタッフ安否確認、診療記録、診療費請求・管理、財務管理（給与振り込み）、スタッフ労務管理	全ステージ 中断しない
縮小継続	定期外来診療（縮小）、検査・処置（緊急のみ）、処方・投薬管理、他機関との連携・調整、記録・書類業務（最低限）	目標： 1ヶ月以内
一時停止	定期健康診断、予防接種（緊急性なし）、スタッフ研修・定例会議、非緊急事務作業、法人内会議・委員会	安全確保後 速やかに再開

※ テンプレートExcelの「業務優先度分類」シートに入力すると、院独自の詳細な業務分類表が生成されます。

3.2 BCPステージングと対応方針

被害状況に応じて4つのステージに分け、対応方針を切り替える。詳細は「ステージ対応表」タブを参照。

第4章 主要業務の継続対策（ボトルネックと代替手段）

4.2 外来診療業務

- **ボトルネック**：診療可能なスタッフ・移動手段の確保、保険証確認の困難（災害時特例措置を事前確認）
- **対応策**：スタッフ不足時は電話診療等による定期処方のみ対応。外来継続困難時は近隣医療機関に代診を依頼、または外来休診とする。

4.3 診療記録・情報管理

ボトルネック

- 使用電子カルテシステム：ORCA（オルカ）
- 電子カルテは停電・ネット障害時に使用不能となる
- 有事の対応記録は後日の診療報酬請求・リスクマネジメントに不可欠

代替手段・対応策

- 停電時の電子カルテ対策：ポータブル電源1台（整備中）
- 紙記録の準備状況：複写式2号紙を30枚ストック済み
- PC複数台・モバイルバッテリーを平時から整備

4.4 通信・情報システム

- **ボトルネック**：最大のボトルネックは通信手段の確保。固定電話・FAXのみでは有事に機能しない可能性がある。サイバー攻撃による電子カルテ停止・情報漏洩リスクもある。
- **対応策**：ICT（SNS・ショートメール・安否確認アプリ）の有事活用ルールを平時から整備。重要患者データの定期バックアップ実施。電子カルテ停止時は複写式紙カルテへ即時切替。
- 行政とのホットライン（港北区福祉保健センター（TEL：045-540-2363））を事前確認し、固定電話・FAX以外の連絡先も取得しておく。

4.5 請求業務・金銭管理

ボトルネック

- 請求しなければ収入が途絶するため最優先業務
- レセプト業務担当：2名 / 代替手段：レセコン業者に依頼可
- 運転資金の確保状況：約2ヶ月分
- 銀行機能停止・口座振替不能の可能性

対応策

- レセプト業務を担えるスタッフを複数育成する（現状：2名）
- 3ヶ月収入が不十分だった場合のキャッシュフローシミュレーションを行っておく
- 政府系・行政の緊急つなぎ資金・助成金制度を事前把握する

4.6 薬剤・衛生材料の確保

- 備蓄状況：消耗品1週間分確保。薬剤は卸業者との緊急対応確認済み。
- 平時から1週間分多めの処方を行い、非常用持ち出し袋への収納を患者に促す
- 処方変更時には持ち出し袋のストックも更新するよう患者・関係職種に周知する

4.7 スタッフのメンタルヘルスと労務管理

- 有事体制スタート後1週間を目安に、個別面談など「吐き出せる場」を設ける
- 特定の人物に業務・意思決定の負荷が集中しないよう、休息と交代の仕組みを決めておく
- 要配慮スタッフ（育児中1名（K.F.））の安全確保を最優先とし、出勤を強めない
- SNS疲れに注意し、情報共有ルール（主要連絡手段：LINEグループ（全スタッフ）・個人携帯）を事前に確立する

第5章 患者への対応方針

5.1 安否確認体制

優先度	対象患者	主な確認方法
A	外来患者（合計：約800名/月）	掲示・SNS・安否確認アプリ

”

5.3 薬剤・衛生材料の確保

- 平時から1週間分多めの処方を行い、非常用持ち出し袋への収納を促す
- 誕生日月に最低年1回、非常用持ち出し袋の薬を確認する

5.4 個別避難支援

- 各患者の個別避難支援計画を確認・未策定の場合は立案を支援する
- 初回訪問時に患者宅のハザードマップ確認・避難場所・移動方法をルーティン化する

5.5 ポジションペーパーの準備

有事の際に患者・家族・関係機関に向けて当院の状況と方針を速やかに発信できるよう、「ポジションペーパー」のひな形を平時から準備しておく。

第6章 他機関との連携体制

6.1 代行 訪問協定

診療提供が困難になった場合に備え、平時から近隣医療機関との支援協定を締結しておく。

現在の状況：近隣クリニックと口頭合意済み・文書化予定

後方支援病院・施設：横浜市立市民病院・横浜労災病院 / 連携訪問看護ST：なし（外来専門のため連携のみ）

6.2 行政・職能団体との連携

- 行政担当窓口：港北区福祉保健センター（TEL：045-540-2363）
- 所属医師会：横浜市医師会・港北区医師会
- 安否確認ができない患者の情報を行政と共有するタイミング・方法について事前協議する
- 通信維持のために、有事でも連絡可能な機関のリストを作成し、固定電話・FAX以外の連絡先も取得しておく

6.3 地域BCP（地域全体での連携）

- 横浜市医師会・港北区医師会を通じた地域BCP体制構築への参加
- 医療・介護・福祉機関・行政とのICT連携（有事の運用ルールを平時から整備）
- 地域全体でのPDD（防ぎ得た災害関連死）ゼロを目指す

第7章 平時からの備え（アクションリスト）

No.	項目	担当	期限目安	状況
1	スタッフ全員でBCPを読み合わせ・合意形成	BCP管理 担当	1ヶ月以 内	☐ 未着 手
2	患者安否確認リストを作成・最新化（A～D優先度付き）	訪問担当	1ヶ月以 内	☐ 未着 手
3	代行訪問協定を近隣医療機関と締結	院長	3ヶ月以 内	☐ 未着 手
4	電子カルテの停電対策を確認・整備	事務	2ヶ月以 内	☐ 未着 手
5	紙記録（複写式2号紙等）を準備	事務	1ヶ月以 内	☐ 未着 手
6	スタッフ全員分のモバイルバッテリー・ヘルメットを購入	事務	1ヶ月以 内	☐ 未着 手
7	3日分の食料・飲料水を確保	事務	2ヶ月以 内	☐ 未着 手
8	在宅酸素・人工呼吸器患者に非常用電源対策を個別相談	訪問担当	2ヶ月以 内	☐ 未着 手
9	災害時の連絡手段（災害伝言ダイヤル171・トランシーバー（検討中））を全 スタッフが使える状態に	BCP管理 担当	2ヶ月以 内	☐ 未着 手
10	代替診療所（近隣公民館・港北区区民センター（事前確認要））を確認・契 約	院長	3ヶ月以 内	☐ 未着 手
11	行政・医師会との連携ルートを確認（港北区福祉保健センター（TEL：045- 540-2363））	院長	3ヶ月以 内	☐ 未着 手
12	レセプト業務の多能工化（担当：2名）	事務長	6ヶ月以 内	☐ 未着 手
13	BCPの年次見直し・訓練計画を立案	BCP管理 担当	6ヶ月以 内	☐ 未着 手
14	電子カルテ・重要データの定期バックアップ体制を整備	事務	3ヶ月以 内	☐ 未着 手
15	サイバー攻撃・通信障害時のオフライン診療手順をスタッフと確認	BCP管理 担当	3ヶ月以 内	☐ 未着 手

第8章 BCP発動手順（初動フロー）

ステップ	アクション	担当	手段
1	自身・家族・患者の安全確保（アクションカードに従って行動）	全スタッフ	各自判断
2	診療所・スタッフの被害状況確認	桜山 太郎 （院長）	LINEグループ（全スタッフ）・個人携帯
3	スタッフ安否確認・参集可能人数の把握	桜山 太郎 （院長）	LINEグループ（全スタッフ）・個人携帯
4	BCP発動宣言・ステージ判定（1～4）	桜山 太郎 （院長）	全スタッフへ周知
5	患者安否確認開始（優先度A→B→C→D順）	全出勤スタッフ	電話（固定・携帯）・LINE・院内掲示・ 安否確認アプリ
6	医療機器使用患者（人工呼吸器・HOT）への緊急訪問調整	訪問担当	バディ（2人組）で行動
7	横浜市医師会・港北区医師会・行政（港北区福祉保健センター（TEL：045-540-2363））へ状況報告	桜山 太郎 （院長）	電話・FAX・横浜市医師会ネットワーク
8	連携機関（横浜市内市民病院・横浜労災病院）へ患者受入等の調整	桜山 太郎 （院長）	電話・FAX・横浜市医師会ネットワーク
9	ステージに応じた業務縮小・再開計画の策定	全スタッフ で協議	定期ミーティング
10	ステージ4（診療中断）の場合：保健所への診療休止届出	桜山 太郎 （院長）	電話・書面（港北区福祉保健センター（TEL：045-540-2363））

改訂履歴	
日付	内容
2026/4/25	BCP自動生成アプリ v3 により初版作成（たたき台）

巻末資料 参考・関連資料

本BCPたたき台の作成にあたり参考にした資料・動画です。スタッフ研修や見直しの際にもご活用ください。

🏢 参考資料0 厚生労働省 医療施設の災害対応のための事業継続計画（BCP）

掲載元 厚生労働省（公式ページ）

収録内容 BCP作成の手引き・BCP策定手順と見直しのポイント（策定編・訓練編）・BCP作成指針・チェックリスト等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/infuenza/kenkyu_00001.html



左のQRコードをスマートフォンのカメラで読み取ると厚生労働省BCPページにアクセスできます。

主な掲載資料：

- ・医療機関（災害拠点病院以外）におけるBCP作成の手引き
- ・令和6年度 BCP策定手順と見直しのポイント（策定編・訓練編）
- ・病院BCPを策定するための手引き（改訂第2版）

📺 参考資料1 J-SPEED 意義・運用概論（YouTube動画）

内容 J-SPEED（災害診療記録）の意義・運用概論。有事に備えたスタッフ研修に活用ください。

形式 YouTube動画

https://youtu.be/j6CzX-c_mRo?si=HghQAaxhU32BL6-N



左のQRコードをスマートフォンのカメラで読み取ると動画にアクセスできます。スタッフ研修・勉強会でのスクリーン投影や、印刷して掲示することを推奨します。

視聴推奨対象：全スタッフ（特に訪問診療スタッフ・記録担当者）
広島県災害診療記録/J-SPEED運用促進事業成果動画

📄 参考資料2 災害診療記録（J-SPEED 2018）一般診療版

書式名 災害診療記録2018 一般診療版 J-SPEED2018（A3両面印刷）

用途 有事の際の診療記録・患者情報の記録（電子カルテ停止時の代替）

J-SPEED（Japan Standard for Primary care in Emergencies and Disasters）は、災害時の診療記録を標準化するための書式です。患者基本情報・バイタルサイン・既往歴・診断・処置・転帰を一枚で記録でき、電子カルテが使えない状況での代替記録として活用します。平時に印刷し事業所に保管することを推奨します。

公式サイト <https://www.j-speed.org/>（様式・運用手順・教育資料を入手できます）

ステージ対応表 | さくら内科クリニック

被害状況に応じて4段階のステージを設定し、各段階での対応を切り替えます。

ステージ	発動条件	スタッフ状況	基本方針	主なアクション
● ステージ1	大規模災害発生直後・被害状況不明	1～2割が参集困難	BCP発動宣言 安否確認開始 優先業務に集中	①桜山 太郎（院長）がBCP発動宣言 ②スタッフ安否確認（LINEグループ（全スタッフ）・個人携帯） ③患者安否確認（A→B→C順） ④施設の被害状況確認 ⑤横浜市医師会・港北区医師会・行政へ報告
● ステージ2	被害状況判明・交通・通信に支障	2～4割が参集困難	優先業務のみ継続 縮小運営	②外来は重症・緊急患者のみ ③パディ（2人組）での行動徹底 ④朝・夕の定期報告実施 ⑤連携施設と患者受入を協議
● ステージ3	被害が広範囲・インフラに重大な支障	5～7割が参集困難	最低限の業務のみ 外部支援を要請	①人工呼吸器・HOT患者のみ対応 ②横浜市民病院・横浜労災病院への移送調整 ③代替拠点（近隣公民館・港北区区民センター（事前確認要））の活用検討 ④自衛隊・医師会支援チームと連携
● ステージ4	復旧の見通しなし・施設使用不能	8割以上が参集困難	診療を一時中断 患者を他機関へ移管	①全患者を横浜市民病院・横浜労災病院へ移管 ②横浜市医師会・港北区医師会・行政に支援要請 ③患者家族・ケアマネへ連絡 ④保健所へ診療休止の届出 ⑤再開の見通しをスタッフへ随時周知

業務優先度分類

分類	業務内容	対応ステージ
優先継続	患者安否確認、スタッフ安否確認、医薬品管理、診療費請求・管理	全ステージ
縮小継続	外来診療（緊急のみ）、処方・投薬管理	ステージ1～2
一時停止	定期健康診断、予防接種（緊急性なし）、スタッフ研修・会議、非緊急事務作業	ステージ3以降

アクションカード | さくら内科クリニック

印刷して各スタッフに配布・携帯してください。Ctrl+P（Cmd+P）で印刷できます。

● 地震・津波 発災直後

★ 自らの安全確保が最優先 | 行動後は診療所または代替拠点へ帰所

診療所にいる場合

- ☐ 自身の安全確保
- ☐ 避難出口の確保
- ☐ 津波リスクあり→上階・高台へ避難
- ☐ ガス・ブレーカーを切る
- ☐ スタッフ安否確認（LINEグループ（全スタッフ）・個人携帯）
- ☐ 患者安否確認を開始（A→B→C順）
- ☐ 桜山 太郎（院長）がステージを宣言

自宅にいる場合

- ☐ 自身・家族の安全確保
- ☐ ガス・ブレーカーを切る
- ☐ LINEで診療所に安否を報告
- ☐ 参集指示に従って行動
- ☐ ※夜間の移動は原則禁止

● 火災 発見直後

★ 通報 → 初期消火（天井到達前のみ） → 避難

STEP1 通報

- ☐ "火事だ！"と大声で叫ぶ
- ☐ 119番通報
- ☐ 院内ベルを鳴らす・隣近所に知らせる

STEP2 初期消火（天井到達前のみ）

- ☐ 消火器：安全ピン→ノズルを火元へ→レバーを握る
- ☐ 炎が天井に達したら直ちに中断し避難

STEP3 避難

- ☐ 燃えている部屋の窓・ドアを閉め空気を遮断
- ☐ 患者・スタッフを屋外へ誘導
- ☐ 濡れタオルで口・鼻をふさぎ姿勢を低くする
- ☐ 外に出たら絶対に戻らない
- ☐ 取り残された人がいたら消防隊に伝える

● 風水害 警戒レベル別

★ 警戒レベルに応じて段階的に対応（情報収集先：小田原ライブビジョン等）

Lv.2 早期注意情報

- ☐ 気象情報を継続収集
- ☐ スタッフの出退勤・シフトを調整
- ☐ 車にガソリンを満タンに補充

Lv.4 避難指示

- ☐ 訪問をキャンセル・電話/オンライン診療へ切替
- ☐ スタッフは自宅待機または避難所へ
- ☐ 患者の避難状況を電話確認

Lv.5 緊急安全確保

- ☐ 命を守る行動を最優先

● 停電 発生時

★ 医療機器患者への対応が最優先

医療機器患者（最優先）

- ☐ 人工呼吸器→内部バッテリーに切替確認
- ☐ HOT→非常用ポンベへ切替・残量確認（業者：なし（HOT患者なし））
- ☐ 吸引機→バッテリー確認・手動式の準備
- ☐ バッテリー残量を診療所に報告

診療所の対応

- ☐ 停電エリアと復旧見通しを確認
- ☐ ブレーカーを上げコンセントを抜く（復電時の機器故障・火災防止）
- ☐ 電子カルテ停止→ポータブル電源1台（整備中）・紙記録へ切替
- ☐ 保健センターへ人工呼吸器患者の状況を報告

- ☐ その場で建物上階へ垂直避難

長期化する場合

- ☐ 近隣医療機関への患者受入を調整
- ☐ 行政・医師会（横浜市医師会・港北区医師会）に支援を要請
- ☐ 発電機（カセット式）を起動

● 感染症 対応

★ 予防期・発生期・流行期の3段階で対応

予防期（平時）

- ☐ 手洗い・マスク・換気の標準予防策
- ☐ PPEのローリングストックを定期確認
- ☐ 感染リスクの高い患者対応スタッフを事前に決める

発生期

- ☐ 会話時マスク必須・2点換気を常時実施
- ☐ 接触ケアあり→ガウン着用
- ☐ 接触感染リスク患者は訪問を最後に回す
- ☐ 体調不良のスタッフは即座に報告

流行期

- ☐ スタッフを2チームに分け交互勤務
- ☐ 空気感染リスク→N95マスク着用
- ☐ 状態安定患者はオンライン診療へ積極的に切替
- ☐ 感染者対応は期間限定で交代制に（特定の人に偏らせない）

■ スタッフ参集・安否確認

★ 連絡手段優先順位：LINEグループ（全スタッフ）・個人携帯・安否確認アプリ → 災害伝言ダイヤル171

参集基準（地震の場合）

- ☐ 震度5強以上→自動参集
- ☐ 震度5弱以下・停電→オンライン参集
- ☐ 通信不通→徒歩・自転車圏内スタッフのみ自主参集
- ☐ 夜間の移動は原則禁止（夜明けを待つ）

安否確認の手順

- ☐ ①LINEグループで一斉送信
- ☐ ②未応答者には個人携帯に電話
- ☐ ③連絡取れない場合はバディで自宅を確認（日中のみ）
- ☐ ④参集可能人数を桜山 太郎（院長）に報告

帰宅困難時

- ☐ 3日分の食料・水を診療所で確保（備蓄：要準備）
- ☐ 診療所または近隣の避難所で待機
- ☐ 翌朝を待って安全確認後に移動

📍 場所別アクションカード | さくら内科クリニック

場所ごとの具体的な行動手順です。印刷してスタッフに配布・携帯してください。

● 地震・津波

● 地震・津波 診療所

【発動】緊急地震速報 or 大きな揺れを感じた時

★自らの安全確保が最優先 | 行動後は診療所（または代替拠点）へ帰所

▶ まず身を守る

- ☐ 自身の安全確保（頭を守る・机の下等）
- ☐ 避難出口の確保（ドアを開ける）

▶ 津波リスクがある場合

- ☐ 揺れが落ち着いたら直ちに上階・高台に避難

▶ 二次災害予防

- ☐ ガスの火を止める
- ☐ 器具栓・ガス栓・メータガス栓を閉める
- ☐ 電気ブレーカーを落とす
- ☐ コンセントを抜く
- ☐ 懐中電灯などの明かりを確保

▶ 管理者：判断・指揮

- ☐ 代替拠点を開設するか判断
→ 開設する場合：スタッフ・行政・関係機関へ周知
- ☐ スマホを「省電力モード」に切替
- ☐ 行政・各種メディアから情報を集約
- ☐ 訪問スタッフの安否・状況を把握（LINE優先）
- ☐ 対応レベル（ステージ1～4）を判断・宣言
- ☐ 患者安否確認を開始（A→B→C→D順）安否確認アプリ等使用
- ☐ 横浜市医師会・港北区医師会・行政へ状況を報告

▶ 参集基準

- ☐ 震度5強以上 → 自動参集
- ☐ 震度5弱以下・停電あり → オンライン参集
- ☐ 通信不通 → 徒歩・自転車圏内スタッフのみ自主参集

● 地震・津波 自宅

【発動】緊急地震速報 or 大きな揺れを感じた時

★自らの安全確保が最優先 | 夜間の移動は原則禁止

▶ まず身を守る

- ☐ 自身・家族の安全確保（頭を守る・机の下等）
- ☐ 避難出口の確保（ドアを開ける）

▶ 津波リスクがある場合

- ☐ 揺れが落ち着いたら直ちに上階・高台に避難

▶ 二次災害予防

- ☐ ガスの火を止める・器具栓・ガス栓を閉める
- ☐ 電気ブレーカーを落とす・コンセントを抜く
- ☐ 懐中電灯などの明かりを確保

▶ 診療所への連絡

- ☐ スマホを「省電力モード」に切替
- ☐ LINEで診療所に安否を報告
- ☐ 参集指示に従って行動（夜間の移動は原則禁止）

▶ 参集の目安

- ☐ 震度5強以上 → 翌朝、安全確認後に参集
- ☐ 通信不通・夜間 → 自宅待機・夜明けを待つ
- ☐ 3日分の食料・水・モバイルバッテリーを確保

● 火災

● 火災 診療所

【発動】火災・煙を発見した時 | 通報 → 初期消火 → 避難の順

★通報→初期消火（天井到達前のみ）→避難

▶ STEP1 通報

- ☐ 「火事だ！」と大声で叫ぶ
- ☐ 119番通報
- ☐ 院内ベルを鳴らす・隣近所に知らせる

▶ STEP2 初期消火（火が天井に届く前のみ）

- ☐ 消火器：安全ピン→ノズルを火元へ→レバーを握る
- ☐ 炎が天井に燃え移ったら直ちに消火を中断し避難

▶ STEP3 避難

- ☐ 燃えている部屋の窓・ドアを閉め空気を遮断
- ☐ 患者・スタッフを屋外へ誘導
- ☐ 濡れタオルで口・鼻をふさぎ姿勢を低くする
- ☐ 外に出たら絶対に戻らない
- ☐ 取り残された人がいたら消防隊に伝える

▶ 避難後・管理者対応

- ☐ 全スタッフ・患者の安否確認
- ☐ 横浜市医師会・港北区医師会・連携機関へ状況報告
- ☐ 代替拠点への移行を判断

● 風水害

● 風水害 診療所

【発動】早期注意情報（Lv.1）から対応を開始

★警戒レベルに応じて段階的に行動

▶ Lv.1 日頃からの備え

- ☐ 3日分の食料・備蓄を確認
- ☐ 非常持ち出し品の点検
- ☐ 患者の避難場所・経路を事前確認

▶ Lv.2 早期注意情報

- ☐ 気象情報を継続収集
- ☐ スタッフの出退勤・シフト調整を検討
- ☐ 車のガソリンを満タンに
- ☐ 電化製品を床から上げる

● 火災 自宅

【発動】火災・煙を発見した時

★自らの安全確保が最優先 | 逃げることを最優先に

▶ STEP1 通報

- ☐ 「火事だ！」と大声で叫び近隣に知らせる
- ☐ 119番通報

▶ STEP2 初期消火（火が天井に届く前のみ）

- ☐ 消火器を使用
- ☐ 炎が天井に燃え移ったら直ちに中断し避難

▶ STEP3 避難

- ☐ 家族を全員屋外へ誘導
- ☐ 濡れタオルで口・鼻をふさぎ姿勢を低くする
- ☐ 外に出たら絶対に戻らない

▶ 診療所への連絡

- ☐ 診療所に状況（自宅火災・出勤可否）を報告
- ☐ 管理者の指示に従って行動

● 風水害 自宅

【発動】早期注意情報（Lv.1）から対応開始

★警戒レベルに応じて段階的に行動

▶ Lv.1～2 事前準備

- ☐ 自宅周辺の手帳マップを確認
- ☐ 非常持ち出し品・食料・水を確認
- ☐ 車のガソリンを満タンに
- ☐ スマホを充電しておく

▶ Lv.3 高齢者等避難

- ☐ 避難が必要か判断・家族と確認
- ☐ 避難する場合：避難場所・経路を確認してから出発

▶ Lv.4～5 避難指示・緊急安全確保

▶ Lv.3 高齢者等避難

- ☐ 移動困難な患者へ避難を喚起（訪問で支援）
- ☐ 訪問スケジュールを見直し・縮小
- ☐ バディ（2人組）での訪問に切り替え

▶ Lv.4～5 避難指示・緊急安全確保

- ☐ 訪問をキャンセル・電話・オンライン診療へ切替
- ☐ スタッフ全員が自宅待機または上階・避難所へ避難
- ☐ 患者の避難状況を電話で確認
- ☐ 通信維持なら電話診療を継続

- ☐ 直ちに避難所または建物上階へ
- ☐ 外出が危険な場合：垂直避難（上階）を優先

▶ 診療所への連絡

- ☐ 自宅エリアの浸水状況・自身の安否をLINEで報告
- ☐ 出勤可否・交通手段を報告

● 感染症

● 感染症 診療所

【発動】地域での感染症発生期以降、管理者の判断で発動

★標準予防策の徹底 | スタッフ間の感染連鎖を防ぐ

▶ 予防期（平時）

- ☐ 手洗い・マスク・換気の標準予防策
- ☐ PPEのローリングストック定期確認
- ☐ 感染リスクの高い患者対応スタッフを事前に決める

▶ 発生期

- ☐ 会話時マスク必須・2点換気を常時実施
- ☐ 接触ケアあり→ガウン着用
- ☐ 体調不良のスタッフは即座に管理者に報告
- ☐ 外来患者の動線を分離（可能な場合）

▶ 流行期

- ☐ スタッフを2チームに分け交互勤務（コホーティング）
- ☐ 空気感染リスク→N95マスク着用
- ☐ 状態安定患者はオンライン診療・電話診療へ積極切替
- ☐ 感染者対応は期間限定・交代制（特定の人に偏らせない）

● 感染症 自宅

【発動】自身または同居者の体調変化を感じたら即報告

★体調変化は即報告 | 出勤判断は管理者が行う

▶ 体調変化時の対応

- ☐ 発熱・咳・倦怠感など体調不良は即座に管理者に報告
- ☐ 同居者の体調変化も報告対象
- ☐ 管理者の指示に従い出勤・就業制限を判断

▶ 感染リスク軽減（勤務外）

- ☐ 発生期：自治体・大手病院に準じた行動制限を遵守
- ☐ 不要不急の外出・会食を自粛
- ☐ 帰宅後の手洗い・うがい・着替えを徹底

▶ 診療所への連絡

- ☐ 自身・家族の体調をLINEで日次報告
- ☐ PCR結果等が判明次第、即座に管理者に連絡

● 停電

● 停電 診療所

【発動】停電発生を確認次第

★医療機器患者への対応が最優先

● 停電 自宅

【発動】停電発生を確認次第

★安全確保後、出勤可否を報告

▶ 即時対応

- ☐ 停電エリアと復旧見通しを確認（電力会社・行政）
- ☐ ブレーカーを上げコンセントを抜く（復電時の機器故障・火災防止）
- ☐ ポータブル電源・発電機を起動
- ☐ 懐中電灯・ランタンで照明確保

▶ 医療機器患者への対応

- ☐ 人工呼吸器・HOT患者に連絡・訪問スタッフを優先派遣
- ☐ 在宅酸素業者（なし（HOT患者なし））に連絡・状況確認
- ☐ バッテリー残量の少ない患者を優先対応

▶ 記録・業務継続

- ☐ 電子カルテ停止 → 紙記録へ切替（複写式2号紙等）
- ☐ 保健センター・横浜市医師会・港北区医師会へ人工呼吸器患者の状況を報告
- ☐ 長期化する場合：連携病院への患者受入を調整

▶ 長期化する場合

- ☐ カセット式発電機を起動（屋外使用・換気必須）
- ☐ 近隣医療機関への患者受入を調整
- ☐ 行政・横浜市医師会・港北区医師会に支援を要請

▶ 自宅の安全確保

- ☐ 懐中電灯・非常灯で明かりを確保
- ☐ 火を使用しない
- ☐ 長期化が予測される場合：ブレーカーを上げコンセントを抜く
- ☐ モバイルバッテリー・車のシガーソケットでスマホ充電

▶ 診療所への連絡

- ☐ 自宅エリアの停電状況をLINEで報告
- ☐ 出勤可否・交通手段を報告

大規模災害時 スタッフ出勤可否表 | さくら内科クリニック

No.	氏名	職種	通勤距離	通勤手段	災害時参集可否	備考
1	S.Y.	医師（院長）	0.8km	徒歩	◎ 徒歩10分以内	
2	H.Y.	医師（副院長）	3.2km	自転車	○ 徒歩・自転車圏内(～4km)	
3	M.S.	看護師長	1.5km	徒歩	○ 徒歩・自転車圏内(～4km)	育児中
4	K.T.	看護師	2.8km	自転車	○ 徒歩・自転車圏内(～4km)	
5	A.N.	看護師	4.5km	自転車	△ 自転車・車で対応(～8km)	
6	R.K.	看護師	12km	電車	▲ 要交通手段	
7	I.S.	臨床検査技師	6.5km	車	△ 自転車・車で対応(～8km)	
8	M.O.	事務長	1.2km	徒歩	○ 徒歩・自転車圏内(～4km)	
9	K.F.	事務	3.5km	自転車	○ 徒歩・自転車圏内(～4km)	育児中
10	T.H.	事務	8km	車	△ 自転車・車で対応(～8km)	
11	N.W.	清掃	0.5km	徒歩	◎ 徒歩10分以内	
12	S.M.	清掃	2km	徒歩	○ 徒歩・自転車圏内(～4km)	

◎：徒歩10分以内（～1km） ○：徒歩・自転車圏内（～4km） △：自転車・車で対応（～8km） ▲：要交通手段

⚠ 要配慮スタッフ：育児中1名（K.F.） → 安全確保を最優先とし出勤を強いない

災害用備品 購入リスト | さくら内科クリニック

優先度： A 最優先（早急に購入） B 推奨（6ヶ月以内） C あると望ましい（1年以内） | ✓ 保有 = Excelで「○」を入力
済みの備品。価格は参考価格です。

優先度	カテゴリー	品目名	用途	目安数量	参考単価	保有状況	備考
A	非常用電源・照明	ポータブル電源（1000Wh以上）	在宅酸素・吸引機・電子カルテPCへの非常用電力供給	2台	約8万円/台	☐ 未購入	Jackery等。往診車用1台含む。ソーラーパネルとセットで購入推奨
A	非常用電源・照明	モバイルバッテリー（20000mAh以上）	スタッフ全員のスマホ充電用	全スタッフ分+3個	約4,000円/個	☐ 未購入	常に充電済み状態で保管。12名+3個
A	非常用電源・照明	LED充電式ランタン	停電時の院内照明	6個	約3,500円/個	☐ 未購入	各部屋に1個配置
A	非常用電源・照明	ヘッドライト（LED）	夜間訪問・個人照明。両手が使える	全スタッフ分	約2,000円/個	☒ 保有	ヘルメットに取付可能なタイプが便利
A	通信・情報	防災ラジオ（手回し充電対応）	停電・通信障害時の情報収集	3台	約5,000円/台	☒ 保有	AM受信必須。往診車にも1台
A	医療・衛生資材	N95マスク	感染症流行期のスタッフ保護・エアロゾル処置時	200枚	約200円/枚	☒ 保有	使用期限に注意。ローリングストック管理
A	医療・衛生資材	手動式吸引器	停電時に電動吸引器が使えない患者への対応	3台	約15,000円/台	☐ 未購入	平時から操作練習を実施
A	スタッフ安全	ヘルメット（折りたたみ式）	地震時の落下物から頭部を保護	全スタッフ分+3個	約3,500円/個	☒ 保有	デスク・鞆に常備可能な折りたたみ型を推奨

優先度	カテゴリ	品目名	用途	目安数量	参考単価	保有状況	備考
A	スタッフ安全	安全靴・作業用手袋	瓦礫・ガラス散乱時の移動・作業	全スタッフ分	約3,000円/セット	☐ 未購入	往診バッグに常備
A	水・食料備蓄	飲料水（2Lペットボトル）	スタッフ3日分（1人/日2L）	全スタッフ×6本	約250円/本	☒ 保有	毎年交換（ローリングストック）
A	水・食料備蓄	非常食（カロリーメイト等）	スタッフ3日分	全スタッフ×3日分	約1,500円/人分	☐ 未購入	賞味期限管理。毎年3月に確認・補充
A	水・食料備蓄	災害用簡易トイレ（凝固剤タイプ）	断水時のトイレ対応。患者・スタッフ共通で必須	50回分以上	約3,000～5,000円/セット	☐ 未購入	袋式凝固剤タイプ推奨。消費期限5年以上のものを選ぶ。簡易テント or 目隠しパーテーションも1つ併せて用意
A	防火・防災設備	粉末消火器（ABC）	院内の初期消火	3本	約5,000円/本	☒ 保有	各部屋に配置。5年毎に点検
B	非常用電源・照明	カセットガス発電機（インバーター式）	電子カルテ・医療機器への電力供給（停電長期化時）	1台	約12万円	☐ 未購入	屋外専用。カセットボンベ30本以上常備
B	記録・事務	複写式診療記録用紙（2号紙等）	電子カルテ停止時の紙記録への切替	500枚～	約25円/枚	☐ 未購入	現状：複写式2号紙を30枚ストック済み
B	移動・搬送	電動アシスト自転車	ガソリン不足・交通渋滞時の参集・往診移動	2～3台	約12万円/台	☐ 未購入	4km以上のスタッフの自転車・車参集用
B	防火・防災設備	土嚢袋または給水型土嚢	風水害時の浸水対策	20～30個	約200～1,500円/個	☐ 未購入	入口・サーバー室周辺に設置

優先 度	カテ ゴ リ	品目名	用途	目安数 量	参考単価	保有 状 況	備考
C	医療・ 衛生資 材	AED（自動体外式 除細動器）	院内・往診中 の心肺停止対 応	1台	約35万円	☐ 未 購 入	リース契約も検討。すでに あれば点検確認を
C	記録・ 事務	タブレット端末 （防水・頑丈型）	電子カルテの オフライン閲 覧・写真記録	2台	約6万円	☐ 未 購 入	重要患者情報をオフライン で閲覧できるよう設定

※ 消耗品（電池・食料・水・PPE等）はローリングストック方式で管理。毎年3月に在庫確認・使用期限チェック・補充を実施すること。